

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

SCPS · ESCALA PRONÓSTICA DE STRAUSS Y CARPENTER

Strauss-Carpenter Prognostic Scale – Evaluación multidimensional de factores pronósticos, funcionamiento laboral, relacional y curso evolutivo en la esquizofrenia

1. Identificación General del Instrumento

Nombre oficial	Strauss-Carpenter Prognostic Scale (SCPS)
Nombre en español	Escala Pronóstica para la Esquizofrenia de Strauss y Carpenter
Sigla oficial	SCPS
Autores originales	John S. Strauss y William T. Carpenter Jr. (1974, 1977)
Adaptación hispanohablante	Estudio Piloto Internacional de Esquizofrenia (IPSS / OMS); Bobes et al. (2004)
Año de publicación original	1974 (modelo de 4 dominios evolutivos del IPSS-OMS)
Construtto primario	Predicción multidimensional del curso clínico, funcionalidad social, empleo y hospitalismo en psicosis
Formato de administración	Heteroaplicada mediante entrevista clínica semiestructurada e historia biográfica del paciente
Población diana	Pacientes adultos diagnosticados de esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme o psicosis afines
Tiempo de aplicación	15 a 25 minutos (revisión de historia clínica y anamnesis de 12 dimensiones)
Régimen de acceso	Uso clínico y de investigación abierto de dominio público (OMS / IPSS)

2. Fundamentación Conceptual y Marco Clínico

La **Escala Pronóstica para la Esquizofrenia de Strauss y Carpenter** (SCPS) surgió de las investigaciones pioneras del **International Pilot Study of Schizophrenia** (IPSS) auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Antes del trabajo de Strauss y Carpenter (1974, 1977), predominaba en la psiquiatría tradicional la asunción kraepeliniana de que la esquizofrenia presentaba un curso invariablemente homogéneo de deterioro global donde la gravedad de los síntomas determinaba directamente el destino social y laboral del enfermo.

Strauss y Carpenter refutaron experimentalmente este paradigma demostrando que el curso de los trastornos psicóticos no es uniprocésal, sino que se divide en **cuatro sistemas o dominios evolutivos semi-independientes**: 1) el funcionamiento laboral y productivo; 2) las relaciones y vínculos sociales; 3) la presencia y gravedad de síntomas psicóticos; y 4) la tasa de hospitalizaciones y cronicidad. Los hallazgos demostraron que el mejor predictor del trabajo futuro no son los síntomas psicóticos, sino la historia laboral previa; y el mejor predictor de la sociabilidad futura son las relaciones premórbidas. La SCPS operativa esta matriz pronóstica multifactorial, constituyendo una herramienta indispensable para la planificación de la rehabilitación psicosocial comunitaria.

3. Dominios Evaluados y Composición de Ítems

Dimensión Pronóstica Clave	N.º Ítems	Rango	Contenido Clínico y Operacionalización
1. Funcionamiento Laboral	2 ítems	0 – 8	Ítem 1 (tiempo en trabajo útil remunerado el último año) e Ítem 2 (calidad y competencia laboral demostrada).
2. Relaciones Sociales / Vínculos	2 ítems	0 – 8	Ítem 3 (frecuencia de contacto con amigos fuera de la familia) e Ítem 4 (intimidad y reciprocidad en las relaciones).
3. Síntomas y Hospitalismo	2 ítems	0 – 8	Ítem 5 (presencia de síntomas psicóticos o alteraciones) e Ítem 6 (tiempo transcurrido hospitalizado el último año).
4. Autonomía y Calidad de Vida	2 ítems	0 – 8	Ítem 7 (capacidad para satisfacer necesidades básicas por sí mismo) e Ítem 8 (disfrute subjetivo de la vida cotidiana).
5. Ajuste Premórbido e Inicio	4 ítems	0 – 16	Ítems 9 (ajuste premórbido previo), 10 (forma de inicio aguda vs. insidiosa), 11 (estresores claros) y 12 (síntomas afectivos).
Puntuación Total SCPS	12 ítems	0 – 48	Suma directa de las 12 dimensiones puntuadas de 0 a 4. Mayor puntuación = mejor pronóstico.

4. Validez, Confiabilidad y Rendimiento Diagnóstico en España / LatAm

Propiedad Métrica	Coefficiente / Hallazgo	Contexto Empírico y Validación Hispana
Fiabilidad interjueces (CCI)	CCI = 0.81 – 0.91	Excelente acuerdo entre psiquiatras y psicólogos clínicos tras revisión biográfica estandarizada.
Consistencia interna	Alpha de Cronbach = 0.80 – 0.84	Buena homogeneidad interna para una escala multidimensional heterogénea en pacientes hispanos.
Validez predictiva longitudinal	$r = 0.52 - 0.65$ (a 2 y 5 años)	Predicción estadísticamente significativa de la reinserción social y laboral a largo plazo.
Validez de constructo factorial	4 factores ortogonales	Confirmación empírica de la independencia entre evolución laboral, red social y remisión sintomática.
Sensibilidad pronóstica	Odds Ratio = 4.1 para recaídas	Puntuaciones bajas (< 20) multiplican por cuatro el riesgo de rehospitализación a los 12 meses.

5. Reglas de Corrección y Cómputo de Puntuaciones

- **Gradación dimensional de 0 a 4 puntos por ítem:**
 - **0 = Muy desfavorable / Déficit muy grave:** Ninguna actividad laboral, aislamiento social absoluto, hospitalización continua > 6 meses, inicio muy insidioso sin estresores.
 - **1 = Desfavorable / Déficit moderado-grave:** Empleo marginal < 3 meses, contactos sociales mínimos, hospitalización prolongada.
 - **2 = Moderado / Déficit intermedio:** Trabajo a tiempo parcial 3-6 meses, relaciones superficiales, síntomas moderados controlados.
 - **3 = Favorable / Buen ajuste:** Empleo casi continuo (7-9 meses), red de amistades activa, síntomas leves sin reingreso.
 - **4 = Muy favorable / Óptimo:** Trabajo a tiempo completo todo el año con excelente desempeño, relaciones ricas, plena autonomía y remisión sintomática.
- **Puntuación Total SCPS:** Suma directa de las 12 dimensiones (rango: 0 a 48 puntos).
- **Direccionalidad favorable:** A mayor puntuación, **MEJOR pronóstico y potencial de rehabilitación**; a menor puntuación, mayor riesgo de cronicidad e invalidez funcional.

6. Baremos Normativos, Puntos de Corte y Estratificación Clínica

Puntuación Total	Estratificación Pronóstica	Evolución Esperada y Planificación Asistencial
0 – 16 puntos	Pronóstico Muy Desfavorable / Severo	Alto riesgo de deterioro crónico e institucionalización. Mínimo soporte social y laboral. Requiere recursos residenciales tutelados.
17 – 28 puntos	Pronóstico Moderado-Desfavorable	Dificultades persistentes en el área ocupacional y vincular. Potencial de rehabilitación condicionado a talleres protegidos y apoyo intensivo.
29 – 38 puntos	Pronóstico Favorable / Bueno	Capacidad preservada para la reinserción comunitaria, empleo adaptado y mantenimiento de vínculos. Baja tasa de reingreso hospitalario.
39 – 48 puntos	Pronóstico Excelente / Muy Favorable	Curso óptimo o episódico con remisión completa intercrisis. Plena capacidad de empleo competitivo y funcionamiento autónomo.

PRINCIPIO CLÍNICO DE STRAUSS Y CARPENTER (1974): Una puntuación deficiente en la dimensión de síntomas (ítem 5) NO predice necesariamente un fracaso en la rehabilitación laboral o social; los planes de reinserción no deben demorarse indefinidamente hasta alcanzar la remisión sintomática total.

7. Algoritmo de Decisión Clínica e Intervención Asistencial

Paso 1: Aplicación tras la estabilización del episodio agudo:

- Evaluar con la SCPS en el momento del alta hospitalaria o en las primeras consultas ambulatorias tras el primer brote psicótico.

Paso 2: Análisis por dominios específicos independientes:

- **Dominio Laboral Bajo (Ítems 1-2 ≤ 2) con Dominio Social Aceptable (Ítems 3-4 ≥ 4):** Derivación a programas de empleo con apoyo (**supported employment** / modelo IPS) o centros especiales de empleo.
- **Dominio Social Bajo (Ítems 3-4 ≤ 2):** Priorizar centros de día, clubes sociales y entrenamiento en cognición social.
- **Ajuste Premórbido e Inicio Favorable (Ítems 9-12 ≥ 10):** Cuadro de mejor pronóstico intrínseco. Optimizar psicofarmacología con antipsicóticos atípicos de bajo perfil sedativo para evitar deterioro cognitivo secundario.

Paso 3: Asignación de recursos sociosanitarios:

- **SCPS < 18:** Derivación a Unidad de Rehabilitación de Media Estancia o Residencia Comunitaria Supervisada.
- **SCPS 18 – 30:** Programa de Continuidad de Cuidados en Salud Mental Comunitaria y Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS).
- **SCPS > 30:** Seguimiento ambulatorio ordinario y retorno paulatino a estudios o empleo ordinario.

8. Caso Clínico Ilustrativo

Identificación: Varón de 23 años, estudiante universitario de informática, dado de alta tras su primer ingreso de 3 semanas por un Episodio Psicótico Agudo de tipo esquizofrénico con delirios de perjuicio y alucinaciones auditivas.

Puntuaciones en la Escala SCPS:

- Puntuación Total SCPS: **35 puntos / 48** (Pronóstico Favorable / Bueno).
- **Desglose de Dominios:**
 - Funcionamiento Laboral/Académico: 6 / 8 (excelente expediente académico previo, estudiaba a tiempo completo hasta el brote).
 - Relaciones Sociales: 6 / 8 (amigos íntimos de la universidad que lo visitaron en el hospital).
 - Síntomas y Hospitalismo: 5 / 8 (remisión parcial con Aripiprazol; 21 días de ingreso hospitalario).
 - Autonomía y Disfrute: 6 / 8 (mantiene autocuidado, motivado por retomar su vida).
 - Ajuste Premórbido e Inicio: 12 / 16 (inicio agudo < 2 meses, estresor claro por exámenes finales, buen ajuste infantil).

Plan de Rehabilitación y Evolución: A pesar de la alarma generada por el brote psicótico, la SCPS identificó un pronóstico francamente favorable gracias a su sólida trayectoria premórbida y su excelente red de apoyo. En lugar de orientarlo a recursos crónicos de baja exigencia, el equipo de salud mental diseñó un plan de reincorporación universitaria parcial con adaptaciones curriculares, psicoterapia cognitivo-conductual para psicosis y psicoeducación familiar. A los 2 años de seguimiento, el paciente completó el grado y se mantiene asintomático con dosis mínimas de antipsicótico.

9. Alertas de Seguridad y Diagnóstico Diferencial

FACTORES DE MAL PRONÓSTICO (RED FLAGS):

- **Inicio insidioso sin precipitantes (Ítems 10 y 11 = 0):** El comienzo larvado con aislamiento progresivo es el predictor biológico más firme de resistencia al tratamiento.
- **Deterioro del autocuidado básico (Ítem 7 = 0):** Indica síntomas negativos severos o déficit ejecutivo avanzado; requiere soporte domiciliario.
- **Hospitalismo recurrente (Ítem 6 = 0):** La “puerta giratoria” hospitalaria erosiona de forma acumulativa los vínculos y la autoestima del paciente.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

- **Esquizofrenia vs. Trastorno Esquizoafectivo:** La presencia de síntomas afectivos prominentes (Ítem 12 = 3 o 4) mejora sustancialmente el pronóstico funcional a largo plazo.
- **Síntomas negativos primarios vs. Secundarios:** Distinguir entre abulia estructural y retraimiento inducido por impregnación neuroléptica (parkinsonismo farmacológico).
- **Depresión postpsicótica:** Evaluar activamente el riesgo suicida en pacientes con buen pronóstico que toman conciencia lúcida de la enfermedad.

10. Referencias Bibliográficas Científicas

1. Strauss, J. S., & Carpenter, W. T., Jr. (1974). The prediction of outcome in schizophrenia: II. Relationships between predictor and outcome variables: A report from the WHO International Pilot Study of Schizophrenia. *Archives of General Psychiatry*, 31(1), 37–42. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.1974.01760130023004>
2. Strauss, J. S., & Carpenter, W. T., Jr. (1977). Prediction of outcome in schizophrenia: III. Five-year outcome and its predictors. *Archives of General Psychiatry*, 34(2), 159–163. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.1977.01770140049005>
3. World Health Organization. (1979). *Schizophrenia: An international follow-up study*. John Wiley & Sons.
4. Bobes García, J., G-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Medica / Psiquiatría Editores.